ANÁLISE DE HEREDOGRAMA

Relatório de história familiar

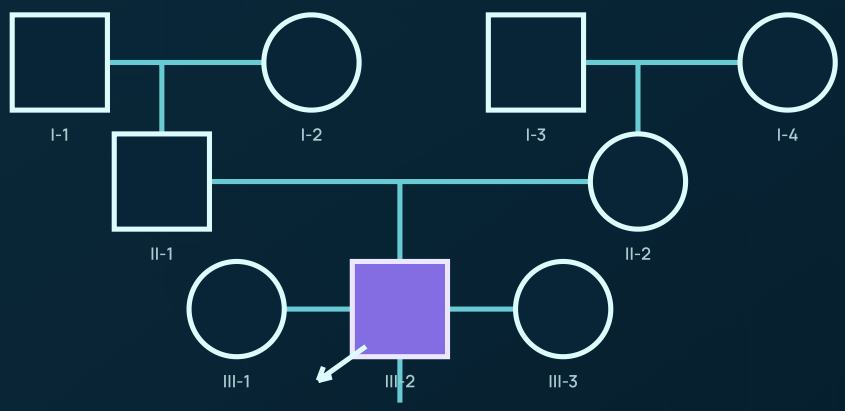
Documento de apoio à avaliação genética, organização fenotípica e interpretação de vínculos familiares.

EDIÇÃO CLÍNICA · 2026

IDENTIFICAÇÃO DO CASO	DATA DE EMISSÃO	STATUS
Família HRYX-024	07 NOV 2026	Revisado
Código do estudo · RPS-2026-024	Versão 1.0	Dados armazenados localmente

VISÃO FAMILIAR

3 GERAÇÕES · 9 INDIVÍDUOS



HIPÓTESE EM AVALIAÇÃO

Padrão de herança autossômica dominante

O heredograma demonstra agregação familiar de manifestação neuromuscular, com indivíduos afetados em gerações sucessivas.

01 · SÍNTESE CLÍNICA

Resumo do caso

Visão consolidada das informações registradas no projeto.

09	03	04	02
INDIVÍDUOS	GERAÇÕES	FENÓTIPOS HPO	AFETADOS

OBSERVAÇÃO CLÍNICA

REGISTRO DO CASO

Probando com início de fraqueza muscular proximal aos 14 anos, progressão lenta e relato de quadro semelhante no ramo materno. Sem consanguinidade informada.

Última atualização — 07 nov 2026 · 14:32

INTERPRETAÇÃO

RESULTADO PRELIMINAR

Compatível com transmissão vertical

A distribuição entre gerações sugere priorizar hipóteses autossômicas dominantes, considerando penetrância variável.

Confiança moderada · 78%

FENÓTIPOS REGISTRADOS

HUMAN PHENOTYPE ONTOLOGY

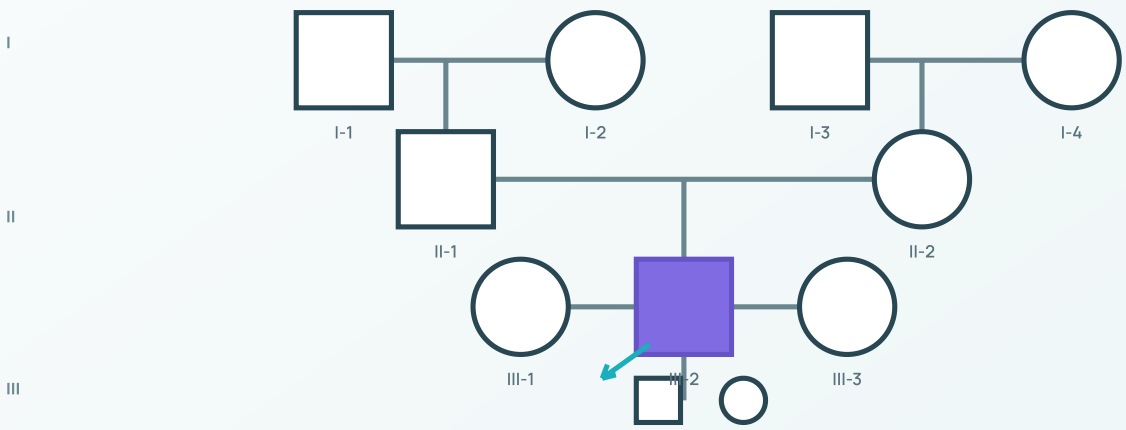
TERMO HPO	DESCRIÇÃO	INDIVÍDUOS	REGISTRO
HP:0003324	Fraqueza muscular geral	III-2, II-2	Confirmado
HP:0003701	Atrofia muscular proximal	III-2	Confirmado
HP:0001250	Convulsões	II-2	Referido
HP:0001263	Atraso global do desenvolvimento	III-2	Em revisão

Validação do projeto concluída
Vínculos familiares consistentes. Dois registros clínicos permanecem pendentes de confirmação documental.

02 · ESTRUTURA FAMILIAR

Heredograma completo

Representação clínica da família fictícia em três gerações.



LEGENDA

Masculino

Feminino

Fenótipo presente

Probando

HISTÓRIA FAMILIAR

SÍNTESE NARRATIVA

A família HRYX-024 foi encaminhada para avaliação após identificação de fraqueza muscular progressiva no probando III-2. A mãe (II-2) refere manifestações semelhantes desde a terceira década de vida. A avó materna (I-4) teria apresentado limitação funcional tardia, sem documentação disponível. Os demais familiares são assintomáticos conforme relato.

Consanguinidade
Não informada

Ancestralidade
Brasileira, não especificada

Ramo prioritário
Materno

Leitura do padrão familiar

Afetados em gerações sucessivas, ambos os sexos representados e possível transmissão vertical. A hipótese permanece preliminar e deve ser correlacionada com avaliação clínica e molecular.

03 · INDIVÍDUOS

Registros clínicos

Dados essenciais dos familiares mais relevantes para a investigação.

PROBANDO · III-2

Indivíduo HRYX-III-02

Masculino · 19 anos · fenótipo presente

EM AVALIAÇÃO

INÍCIO DOS SINTOMAS	CONDIÇÃO PRINCIPAL	SEGUIMENTO	TESTE MOLECULAR
14 anos	Fraqueza muscular proximal	Neurologia e genética	Não realizado

Relata dificuldade progressiva para subir escadas e levantar-se de assentos baixos. Exame inicial sugere redução de força em cinturas pélvica e escapular.

II-2 · MÃE

Indivíduo HRYX-II-02

IDADE	FENÓTIPO	INÍCIO
43 anos	Presente	28 anos

Fraqueza proximal leve e elevação de CK referida em prontuário externo.

I-4 · AVÓ MATERNA

Indivíduo HRYX-I-04

IDADE	FENÓTIPO	INÍCIO
71 anos	Incerto	Após 50 anos

História referida de limitação para marcha. Ausência de registros clínicos comprobatórios.

COMPARAÇÃO CLÍNICA

INDIVÍDUOS PRIORITÁRIOS

Característica	III-2	II-2	I-4
Fraqueza proximal	Presente	Presente	Referida
Atrofia muscular	Presente	Ausente	Não informado
Convulsões	Ausente	Referida	Não informado
CK elevada	Em análise	Referida	Não informado

04 · EVOLUÇÃO E INTERPRETAÇÃO

Linha do tempo clínica

Eventos relevantes registrados durante a investigação fictícia.

2021 — 14 ANOS

Primeiros sinais

Dificuldade para acompanhar atividades esportivas e subir escadas.

2023 — 16 ANOS

Avaliação neurológica

Redução de força proximal; fisioterapia motora iniciada.

2025 — 18 ANOS

História familiar ampliada

Identificação de manifestação semelhante na mãe e possível caso na avó materna.

2026 — 19 ANOS

Encaminhamento para genética

Heredograma estruturado, termos HPO registrados e investigação molecular proposta.

ANÁLISE DO PADRÃO

HIPÓTESES PRIORIZADAS

01	**Herança autossômica dominante** Hipótese principal: transmissão vertical e ambos os sexos potencialmente afetados.	ALTA
02	**Herança ligada ao X** Hipótese alternativa a depender da confirmação fenotípica no ramo materno.	MODERADA
03	**Fenocópia ou etiologia multifatorial** Considerar se os achados clínicos não forem molecularmente concordantes.	BAIXA

Pendências antes da conclusão

- Confirmar documentação clínica da avó materna I-4.
- Revisar resultado de CK da mãe II-2.
- Realizar avaliação cardiológica e respiratória do probando.
- Discutir estratégia de teste molecular em aconselhamento genético.

05 · MÉTODOS E REFERÊNCIAS

Base da análise

Critérios, limitações e fontes utilizadas na elaboração do relatório.

01 **Construção do heredograma**

Estrutura familiar organizada em três gerações conforme convenções padronizadas de nomenclatura e representação gráfica.

02 **Descrição fenotípica**

Achados codificados com termos da Human Phenotype Ontology, versão consultada em novembro de 2026.

03 **Inferência do padrão de herança**

Priorização baseada exclusivamente na distribuição familiar registrada e sujeita à confirmação clínica e molecular.

LIMITAÇÕES

LEITURA OBRIGATÓRIA

- Informações familiares podem conter imprecisões de memória ou registros incompletos.
- Ausência de manifestação não exclui penetrância reduzida ou início tardio.
- Este relatório não estabelece diagnóstico e não substitui aconselhamento genético.
- As hipóteses devem ser revistas quando novos dados forem adicionados.

LITERATURA ESSENCIAL

REFERÊNCIAS

1. Richards S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants. Genet Med. 2015.
2. Köhler S, et al. The Human Phenotype Ontology in 2021. Nucleic Acids Res. 2021.
3. Bennett RL, et al. Standardized human pedigree nomenclature: update and assessment. J Genet Couns. 2008.

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

Nome e registro profissional

DATA DA REVISÃO

____ / ____ / ____

Documento demonstrativo. Todos os nomes, identificadores e dados clínicos apresentados neste modelo são fictícios e foram criados exclusivamente para visualização do relatório Heryx.